

إسم المريض رابعياً : صابرين عبدالفتاح احمد على

الحى / المدينة : الهرم

المحافظة : الحيزه

رقم البطاقة : 28105170101245 رقم التلفون : 01112191521

العمر(تاريخ الميلاد) : 17-05-1981 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

GR I-E
رستم خیل
لڈی حسن
موسین رستم
صحة الاشیاء المرفقة
للجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم حمة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جہۃ العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صابرین عبدالفتاح احمد علي National ID: 28105170101245	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢١/٠٧ ٢٨١٠٥١٧٠١٠١٢٤٥
رؤية منزل

التي مسلمة
سيد محمود احمد علي
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/٠٧



وزارة الداخلية
بطاقة تحقيق الشخصية



صابرين
عبد الفتاح احمد علي
٧ ش عبدالكريم صلاح - الطابية
الهرم - الجيزة

٢٨١٠٥١٧٠١٠١٢٤٥



IY7751767

21-2-2022



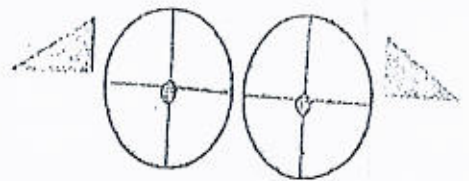
إدارة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
لصحة
المرأة

MDT FORM

4.98
C.CI

Name	رانيا محمد كبر القنديل
Age	40
MRN	
ID	581'617'1'190
Co morbidity	11C1707



Clinical Data

Bx: IDC	SM:
IHC: ER: 8/8 PR: 4/8 Her2: +3 KITV:	Mets Workup:
YPT2 N0 M0 (b master)	
COMMENT: left SSM + SLN. done 25-1-2022	

MDT OUTCOME & PLAN

- for
- PORT to left C.U + SC
 - Adjuvant Kadoxla x 12 cycles
 - Adjuvant hormonal Ht aromidex + zoladex

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

Patient Name : الأستاذ / عماد الدين عبد الفتاح احمد على
Patient No. : 28105170101245
Path No. : 240/22
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000888
Request Date : 25/01/2022
Verification Date : 14/02/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer. Post neoadjuvant chemotherapy.

Nature of the specimen:

Left skin sparing mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy

Gross Examination:

4 specimens were received:

- 1- Left skin sparing mastectomy measured 21x18x3cm. Cut section revealed two masses:
1st mass: A fairly defined greyish white firm mass measured 2.5x2x1.5cm, 1.5cm away from deep margin and 0.5cm away from superficial margin.
2nd mass: An ill-defined greyish white rubbery mass measured 4x3x3cm, close to superficial margin and 2cm away from deep margin.
- Base of nipple specimen: A fibrofatty tissue piece measured 3x2.5x0.5cm. Cut section showed fine nodularity under the nipple.
- Most superficial part of nipple specimen: A fibrofatty tissue piece measured 2x2x1cm
- Sentinel lymph nodes specimen: enclosing 6 nodules up to 1.5cm.

Microscopic examination:

- Histological type: Bicentric tumour.

First mass showed extracellular mucin.

Second mass showed extensive scarring and microscopically single cells and tubular

able moderately anaplastic ductal epithelial cells.

lymph node involvement: Free (0/6) scarred LNs (effect of therapy)

Resection Margins: Free

Histologic response to therapy: Good incomplete response to therapy

Additional pathologic findings: Free base of nipple

Verified by :

Printing Date : 14/02/2022 12:45:36

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name	: الأستاذ / صابر بن عبد الفتاح احمد على	Request No.	: 13000888
Patient No.	: 28105170101245	Request Date	: 25/01/2022
Path No.	: 240/22	Verification Date	: 14/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام ناز المسام - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:

Left skin sparing mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy:

- Bicentric residual tumour cells
- Free margins
- Free base of nipple
- Free scarred (0/6) nodules (effect of therapy)
- Stage: The large mass ypT2
The small mass ypT1 (ml)
Nodes: ypN0

Prof. Aml Hareedy
Dr. Menna Atef

Verified by :

Printing Date : 14/02/2022 12:45:36

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed you

Patient Name : الأستاذ / صابر بن عبد الفتاح أحمد علي
Patient No. : 28105170131245
Ph No. : SR-474
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 136009
Request Date : 23/09/2021
Verification Date : 26/09/2021
Financial Category : نفقة الدولة - ارقام دار السلام
Department : Out Patient

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (as per the involved report)

Preparation of the specimen: Slide revision

Gross Examination: One block and three slides labeled (5511-21) and three stained slides labeled by the patient name.

Procedure: Slide revision

Localization: Left

Immunohistochemistry technique: N/A

Microscopic examination:

Histological type: Invasive micropapillary carcinoma

Grade : G II

Lymphovascular invasion: yes

Ductal carcinoma in situ: yes

Diagnosis:

Left breast mass, Slide revision;

Invasive micropapillary carcinoma, grade II

Immunohistochemistry markers:

ER: Strong 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)

PR: Moderate 40% nuclear reaction (Allred score 6/8)

HER2: Strong complete >10% membrane reaction (score 3+)

Prof. Dr./Garnal Abd El Aty
Dr. Mona Mohamed

Print Date : 26/09/2021 09:35:49

Page 1 of 2

Printing By : mona mohamed

Patient Name: Sabreen Abdel Fatah Ahmed	Date : 5/03/2026
Exam : Ultrasound ABDOMEN & PELVIS	

**ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND
EXAMINATION REVEALED:**

The liver measures 15.5cm at MCL and bright homogenous. No focal lesion is seen. No intrahepatic biliary dilatation is noted.

The gallbladder appears normal with no stones or mud. The common bile duct is normal in caliber.

The pancreas is masked by gases.

The spleen is average in size, homogenous.

Both kidneys are normal in size and shape and echogenicity. No stones or dilated pelvicalyceal system

The urinary bladder is normal in appearance.

No adnexal mass or cyst or free fluid is seen.

No ascites is noted.

OPINION

bright liver most likely fatty for lab correlation

Best regards

Dr. Mahmoud Ashour

Name : SABRIN A.EL FATAH AHMED

Date : 05-03-2026 01:32

Branch : Portable

Medical No. : GRI-30952021

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

**RIGHT DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH RESOLUTION
SONOGRAPHY REVEALED:**

CLINICAL SUMMARY:

Left MRM, followed by implant reconstruction

FINDINGS:

RIGHT BREAST:

Fairly dense fibro-glandular densities, (ACR B).
No spiculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
Complimentary U/S demonstrated no solid or cystic lesion.
Normal skin/nipple/areola complex.
Non-specific axillary nodes.

LEFT MASTECTOMY BED.

Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
Intact implant, with no intra or extra capsular rupture.
Clear left axilla, and no pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

CONCLUSION:

- Right breast (BIRADS 1): normal study
- Clear left mastectomy bed

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar



Name : Sabrin Abdelfatah Ahmed

Date : 13/1/2022

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST :-

Findings:

- Left breast UIQ parenchymal mass is seen measuring 1.7x 1.5 cm. Associated several pathological left axillary LNs are also noted.
- No pulmonary parenchymal masses, consolidation or cavitary lesions.
- Bilateral para-cardiac as well as left basal ,pulmonary atelectatic bands are noted.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes, on non-enhanced CT basis.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- **No Ct evidence of chest infection.**

Dr. Peter Nashaat, MSc

Dr. Amr Farouk MD

PATIENT NAME: SABRIN ABD EL FATAH AHMED ALI	PATIENT ID #: 2021161275
GENDER: Female	ORDER #: 1180900
AGE: 40 y	DATE OF SERVICE: 17-Aug-2021 01:27 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP:

Findings:

Degenerative changes at dorso-lumbar vertebrae.

Otherwise, the rest of surveyed skeleton is free from definite serious lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Recommendation

Follow up bone scan is recommended.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

19-Aug-2021 02:50 PM